



**ДЕРЖАВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР
ТЕСТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З
ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ «МЕДИЦИНА» І
«ФАРМАЦІЯ» ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

ID здобувача / Student ID							
3	8	2	1	1	1	5	2

Прізвище / Surname							
С	О	Л	О	М	К	А	

Варіант / Variant 54

**ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ
СКЛАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІНТЕГРОВАНОГО
ІСПИТУ**

КРОК 3

**Спеціальність
«ФІЗИЧНА ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНА
МЕДИЦИНА»**

1. Пацієнт із травмою спинного мозку в середньогрудному відділі проходить післягострий період реабілітації. Під час проведення обстеження лікар ФРМ виявив, що у пацієнта знижена тактильна, температурна та больова чутливість з обох боків нижче від рівня ураження. Який тип чутливих розладів спостерігається в пацієнта?

- А. Сегментарний
- В. Корковий
- С. Периферичний
- ✓ D. Провідниковий
- Е. Дисоційований

2. Який стан є протипоказанням до призначення ботулінотерапії?

- А. Нейропатичні болі
- В. Фантомні болі
- С. Мігрень
- ✓ D. Оромандибулярна дистонія
- ✓ Е. Порушення нервово-м'язової передачі

3. Пацієнтці складно виконувати швидко чергування рухів під час проведення неврологічного тестування. В анамнезі: тяжка черепно-мозкова травма. Яке порушення спостерігається у пацієнтки?

- А. Атаксія
- ✓ В. Дисметрія
- С. Дизартрія
- Д. Дисфагія
- ✓ Е. Адіадохокінез

4. Пацієнтці з контрактурою правого плечового суглоба призначено пасивні вправи для збільшення обсягу рухів 2 рази на день по 20 повторень у кожній площині у безболісному діапазоні. Який елемент дозування терапевтичних вправ потрібно ще врахувати відповідно до формату FITT?

- ✓ А. Загальну тривалість виконання комплексу вправ
- В. Кількість енергії, що обмежує певну інтенсивність вправ
- С. Прогресування (зміну частоти, інтенсивності та складності вправ із часом)
- Д. Рівень навантаження в кілограмах
- Е. Амплітуду рухів у градусах

5. До стабілізаційного пункту принесли пораненого з ознаками кульового ураження шийного відділу хребта. Що є клінічною ознакою першої стадії спінального шоку?

- А. Арефлексія нижче рівня ураження
- В. Спастичність і гіперрефлексія у кінцівках
- С. Поява бульбокавернозного рефлексу
- Д. Кома
- ✓ Е. Зниження артеріального тиску, збільшення частоти дихання, пульсу

6. Після завершення курсу амбулаторної реабілітації дев'ятирічна дитина з діагнозом: ДЦП — спастична диплегія, GMFCS III — отримала рекомендації щодо подальшого користування ортезами для полегшення здатності ходити. Який вид ортезів рекомендований для нижніх кінцівок дитини в цьому разі?

- А. Шарнірний
- В. Безшарнірний
- ✓ С. Фіксуєчий
- Д. М'якої фіксації
- Е. Розвантажувальний

7. Пацієнт віком 45 років скаржиться на зниження пам'яті, труднощі під час концентрації уваги, не вірить у своє одужання, вважає себе тяжкохворим. Із анамнезу відомо, що нещодавно він переніс інфаркт міокарда. Об'єктивно спостерігається: орієнтований у повному об'ємі, фон настрою знижений, астеничний, суїцидальні думки заперечує. Шукає співчуття і співпереживання. Який провідний синдром у цього

го пацієнта?

- А. Астено-депресивний
- В. Паранояльний
- С. Істеричний
- Д. Обсесивний
- Е. Астенічний

8. Що включає в себе оцінювання менеджменту у фізичній і реабілітаційній медицині?

- А. Оцінку якості та доступності послуг
- В. Визначення плану реабілітації
- С. Оцінку стану здоров'я пацієнта
- Д. Аналіз фінансової ефективності лікування
- Е. Аналіз ефективності використання ресурсів

9. Пацієнт віком 47 років має ревматоїдний артрит у фазі стійкої ремісії. Більше 2-х років приймає глюкокортикостероїдні препарати для контролю інтенсивності запалення. Які корекції найбільш доцільно здійснити з урахуванням безпеки проведення терапевтичних втручань?

- А. Призначити вправи для розвитку рівноваги
- В. Обмежити застосування силових вправ
- С. Обов'язково включити вправи на кардіореспіраторну витривалість
- Д. Обмежити застосування вправ швидко-силової спрямованості
- Е. Знизити інтенсивність проведення пасивних вправ

- 10. Пацієнта шпиталізовано з приводу спінальної травми шийного відділу хребта. Об'єктивно спостерігається: втрата рухової функції, порушення чутливості. Пацієнт іммобілізований, довгий час перебуває в лежачому положенні на спині. У якому місці найчастіше утворюються пролежні за таких умов?

- А. Лопатки
- В. П'ятки
- С. Крижова кістка
- Д. Сідниці
- Е. Гомілки

11. Пацієнт віком 27 років скаржиться на біль у спині, який турбує його протягом останніх 3-4 місяців. Біль зменшується після занять фітнесом, але посилюється після сну чи відпочинку. Під час огляду виявлено значне обмеження обсягу рухів у грудному, поперековому та крижовому відділах хребта в сагітальній і фронтальній площинах. За даними комп'ютерної томографії встановлено ознаки анкілозивного спондилоартриту (хвороби Бехтерева). Які характерні рентгенологічні ознаки цієї патології?

- А. Увігнутість замикальних пластинок тіл хребців трьох та більше сегментів хребта
- В. Двосторонній сакроілеїт II-IV стадії
- С. Зниження висоти дисків поперекового відділу хребта на тлі спондильозу
- Д. Наявність осифікації передньої поздовжньої зв'язки та капсул міжхребцевих суглобів
- Е. Деформація суглобових відростків із ознаками форамінального стенозу

12. Пацієнт після ампутації нижньої кінцівки готується до протезування. Які медичні інтервенції мають бути включені до індивідуальної програми реабілітації?

- А. Ігрова/рекреаційна терапія
- В. Тренування навичок, що стосуються використання допоміжних або адаптивних засобів, пристроїв чи обладнання
- С. Профілактичне консультування або навчання
- Д. Допомога з діяльністю, пов'язаною з веденням домашнього господарства
- Е. Тренування навичок, що стосуються навчання

13. Лікар ФРМ обстежує пацієнта із травмою спинного мозку. Який інструмент потрібно використати для оцінки тяжкості пошкодження спинного мозку?

- А. MMSE
- В. Тест Берга
- С. Шкалу Морзе
- ✓D. Шкалу ASIA
- Е. Шкалу Освестрі

14. Пацієнт віком 45 років звернувся зі скаргами на хронічний біль у попереку, який триває більше двох років. Він пройшов кілька курсів лікування, зокрема приймання знеболювальних препаратів і пасивні методи терапії (масаж, електротерапія). Незважаючи на це, біль не зникає повністю та пацієнт обмежує свою фізичну активність через страх погіршення стану. Який підхід буде найоптимальнішим для планування подальших реабілітаційних втручань?

- А. Використання винятково пасивних методів лікування, зокрема масажу та електротерапії
- ✓В. Інтеграція багатопрофільного підходу з фокусом на активну терапію та пацієнт-орієнтовану реабілітацію
- С. Ігнорування психологічних аспектів болю та зосередження лише на фізичних втручаннях
- Д. Вибір лише тих втручань, які впливають на рухову активність пацієнта
- Е. Зосередження на фармакологічній терапії для зменшення болю

15. Пацієнтка віком 14 років скаржиться на постійні напади пітливості, головокружіння, головного болю, зокрема під час виконання незначних фізичних навантажень. Лікар ФРМ вирішив дослідити співвідношення активності симпатичного та парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи. Який діагностичний інструмент доцільно використати, щоб виконати встановлене завдання?

- А. Індекс Скібінські
- В. Індекс Кердо
- С. Індекс Хільдебранта
- ✓D. Кліностатичну пробу
- Е. Ортостатичну пробу

16. Спортсмена, який отримав травму передньої хрестоподібної зв'язки, готують до реконструктивної операції. Які засоби доцільно застосувати у передопераційній фазі для покращення подальших результатів?

- А. Повний спокій і уникнення будь-яких фізичних вправ до операції
- ✓В. Вправи для зміцнення м'язів навколо колінного суглоба
- С. Збільшення осьового навантаження на травмовану кінцівку
- Д. Накладання гіпсової пов'язки для іммобілізації коліна до операції
- Е. Прийом тільки знеболювальних препаратів для зменшення болю

17. Який із методів дослідження може використовуватися лікарями ФРМ під час обстеження пацієнтів із компресійними та травматичними невропатіями верхніх кінцівок із метою оцінювання функціональної здатності м'язів і розробки алгоритму застосування засобів фізичної терапії?

- ✓А. ММТ (мануальне м'язове тестування)
- В. НМГ (нейроміографія)
- С. ВЕМ (велоергометрія)
- Д. МРТ (магнітно-резонансна томографія)
- Е. КТ (комп'ютерна томографія)

18. Пацієнтку шпиталізовано у стаціонарне реабілітаційне відділення з післяінсультним правобічним геміпарезом. Під час огляду правої верхньої кінцівки виявлено: приведення та внутрішня ротація плеча, згинання в ліктьовому суглобі, пронація передпліччя, згинання кисті та пальців. Пацієнтку забезпечили утримувальним ортезом на плече-лікоть. Який іммобілізаційний ортез потрібний для променево-зап'ясткового суглоба

та кисті в цьому разі?

- ✓ А. Функціональний
- В. Безшарнірний
- С. Для контролю рухів
- Д. Розвантажувальний
- Е. Шарнірний

19. Пацієнтка віком 23 роки отримала забій головного мозку під час ДТП. Лікар ФРМ встановив IV рівень за Шкалою когнітивного функціонування Ранчо Лос Амігос. Укажіть особливість проведення реабілітаційної програми для цієї пацієнтки.

- А. Зменшення вербальних і мануальних підказок
- В. Включення в програму вправ із постурального контролю
- С. Обов'язкове проведення функціональних тренувань у реабілітаційному залі
- ✓ Д. Зменшення стимулів, які викликають збудження
- Е. Прогресивне збільшення складності та швидкості завдань

20. У дитини віком 14 років з ДЦП спостерігається виражений патерн спастичності у вигляді приведення стегна. Лікарем ФРМ введено ботулотоксин у великий привідний м'яз. Які результати очікуються в цьому разі?

- ✓ А. Полегшення гігієни періанальної зони
- В. Покращення функції сидіння
- С. Покращення опори на п'ятку
- Д. Покращення ходьби
- Е. Полегшення під час носіння взуття

21. Пацієнт віком 52 роки, переніс стентування 1-ї коронарної артерії після гострого коронарного синдрому, ФВ становить 54%, відсутні коморбідні захворювання. Із сімейного анамнезу відомо, що пацієнт самостійно виховує двох неповнолітніх дітей. Якою є довготривала ціль для цього пацієнта?

- А. Відновлення ходьби
- В. Відновлення професійної активності
- ✓ С. Ведення домашнього господарства
- Д. Відновлення самообслуговування
- Е. Підтримання здоров'я

22. Військовослужбовець віком 34 роки надійшов до реабілітаційного відділення після мінно-вибухового пошкодження. У нього діагностовано ознаки вторинного мінно-вибухового пошкодження. Які травми є найбільш типовими в цьому разі?

- А. Проникаючі осколкові поранення
- В. Ушкодження легень
- ✓ С. Ушкодження барабанної перетинки
- Д. Травматичні ампутації
- Е. Опіки

23. Пацієнт, відповідно до методики тесту, прийняв вихідне положення, сидячи на підлозі з розігнутими в колінних суглобах нижніми кінцівками та за пропозицією лікаря ФРМ виконав згинання тулуба з максимальним дотягуванням кистями рук. Розтяжність яких структур організму можна оцінити за допомогою цього тесту?

- А. М'язів шиї, плечей і верхньої частини спини
- В. М'язів верхньої частини тулуба та шиї
- С. Підколінних сухожил'я
- Д. Ахіллового сухожилля
- ✓ Е. Підколінних сухожил'я і нижньої частини тулуба

24. Пацієнтка віком 54 роки перебуває у відділенні інтенсивної терапії з діагнозом: коронавірусна хвороба (COVID-19), тяжкий перебіг, ЧД — 28/хв, сатурація SpO_2 — 91%, інфільтрати в легенях більше ніж 50% легеневого поля. Пацієнтка гіпомобільна, скаржиться на загальну слабкість, слабкість у кінцівках, задишку під час мінімаль-

них рухів. Для роботи з пацієнткою залучені фахівці з відділення реабілітації. Як називається така модель роботи мультидисциплінарної реабілітаційної команди?

- А. Мобільний режим надання реабілітаційної допомоги
- В. Реабілітація в територіальних громадах
- С. Реабілітація за вимогою
- Д. Групова реабілітація
- Е. Індивідуальна реабілітація

25. На черговому засіданні міської ради затверджено положення щодо включення ранньої реабілітації до плану ліквідації можливих наслідків воєнних конфліктів в охороні здоров'я з чітким розподілом функцій фахівців із реабілітації та визначенням реабілітаційних маршрутів. До якого з етапів боротьби зі стихійними лихами належить ця активність?

- А. Відновлення
- В. Реагування
- С. Пом'якшення наслідків
- Д. Готовності
- Е. Прогнозування

26. Лікар ФРМ планує оцінити стан когнітивних функцій у пацієнта з ішемічним інсультом. Який інструмент оцінювання доцільно застосувати?

- А. Монреальську шкалу
- В. Шкалу Ашворта
- С. Шкалу Освестрі
- Д. Модифіковану шкалу Ренкіна
- Е. Шкалу Морзе

27. У пацієнта віком 45 років протягом двох років спостерігається сильний біль у ділянці зап'ястя, який посилюється при щипкових діях і ліктьовій девіації, прийом анальгетиків майже не покращує стан. Останнім часом знизилася сила у великому та вказівному пальцях. Періоди перерв у праці, 4 цикли реабілітації та локальні ін'єкції стероїдних препаратів не принесли значного полегшення. Ука-

жіть найбільш оптимальну тактику лікування в цьому разі.

- А. Операція з подовження сухожилля зап'ястка
- В. Артрорез зап'ястка
- С. Хірургічна декомпресія
- Д. Призначення терапевтичних вправ на розтягнення м'яких тканин
- Е. Збільшення дози анальгетиків

28. У результаті перенесеної черепно-мозкової травми у пацієнта спостерігається часткове порушення поверхневої чутливості та сприйняття болю. Об'єктивно: під час дослідження уколом голкою з'являється надмірно інтенсивний біль на окремих ділянках шкіри. Який тип порушення чутливості спостерігається у пацієнта?

- А. Алодинія
- В. Дизестезія
- С. Гіперестезія
- Д. Гіпералгезія
- Е. Парестезія

29. Пацієнт скаржиться на неможливість самостійно розігнути праву кисть і пальці. Під час гоніометрії обсяг пасивного розгинання у правому променево-зап'ястковому суглобі становив 90°. Сила м'язів, що розгинають кисть і пальці, становила 2/5 балів за ММТ. Із анамнезу відомо, що 2 місяці тому в пацієнта був перелом правої плечової кістки. Яке діагностичне припущення можна встановити в цьому разі?

- А. Несвоєчасно встановлене пошкодження м'язів, що розгинають ліву кисть
- В. Пошкодження серединного нерва
- С. Пошкодження променевого нерва
- Д. Суглобова контрактура променево-зап'ясткового суглоба
- Е. Нормальний процес відновлення

30. У пацієнта після транстібіальної ампутації правої кінцівки почала розвиватися згинальна контра-

ктура колінного суглоба. У комплексі підготовки до протезування, які м'язи потрібно зміцнити?

- ✓ А. Розгиначі кульшового суглоба
- ✓ В. Розгиначі колінного суглоба
- С. —
- Д. Згиначі колінного суглоба
- Е. Згиначі кульшового суглоба

16 31. У пацієнта віком 80 років під час профілактичного обстеження виявлено: АТ — 160/100 мм рт. ст., ЧСС у спокої — 60/хв. Для профілактики розвитку ішемічної хвороби серця фізичний терапевт призначив аеробні терапевтичні вправи в межах цільової зони від 70% до 80% від максимальної частоти серцевих скорочень. Розрахуйте цільову частоту серцевих скорочень.

- ✓ А. 98-112/хв
- В. 116-124/хв
- С. 104-124/хв
- Д. 130-140/хв
- Е. 150-160/хв

12 32. У пацієнта віком 27 років після кульового поранення нижньої третини гомілки на відстані 5 см від стопи пошкоджено гілку малого гомілкового нерва, внаслідок чого втрачено функцію розгинання стопи. Яким є очікуваний термін відновлення функції стопи за нормальних умов?

- А. До 18-ти місяців
- 1 В. До 9-ти місяців
- С. До 6-ти місяців
- Д. До 1-го місяця
- Е. До 3-х місяців

14 33. Пацієнта віком 75 років шпиталізовано з початковою стадією деменції, що погіршує його здатність виконувати повсякденні завдання. За результатами застосування тесту MMSE отримано 22 бали. Мультидисциплінарна команда розробляє програму реабілітації. Який із нижченаведених методів найбільше сприятиме покращенню когнітивних функцій у цього пацієнта?

- А. Соціальна активність
- В. Призначення медикаментозних засобів
- ✓ С. Дієта, багата на антиоксиданти
- ✓ Д. Тренування пам'яті та уваги
- Е. Регулярні фізичні вправи

15 34. Під час обстеження пацієнта з перенесеним гострим порушенням мозкового кровообігу за геморагічним типом лікар ФРМ фіксує порушення мовлення. Відзначається утруднення при вимові деяких звуків та їх поєднань, мова невиразна, нечітка, малозрозуміла з укороченим видихом на фоні прискореного та переривчастого дихання. При цьому зміст і логічність висловлень збережені, пацієнт розуміє звернення до нього мовлення. Яке порушення мовлення виникло в пацієнта?

- ✓ А. Дизартрія
- В. Дисфонія
- С. Алалія
- Д. Афазія
- Е. Вербальна апраксія

35. Під час виконання бойового завдання військовослужбовець віком 27 років отримав кульове поранення в ділянці шийного відділу хребта. Лікар ФРМ наполягає на переведенні пораненого з палати інтенсивної терапії до відділення реабілітації. Яка клінічна ознака буде свідчити про закінчення стадії спінального шоку?

- А. Зникнення бульбокавернозного рефлексу
- В. Фібрилярні посмикування м'язів обличчя
- ✓ С. Нормалізація артеріального тиску, пульсу, температури тіла
- Д. Зникнення сухожилкових рефлексів
- Е. Поява бульбокавернозного рефлексу

36. Пацієнт віком 36 років із розсіяним склерозом звернувся до лікаря ФРМ зі скаргами на спастичність м'язів розгиначів стегна та гомілки.

ки, а також м'язів плеча, внаслідок чого виникають обмеження під час ходьби та здатності до самостійного харчування. Який діагностичний інструмент доцільно застосувати для оцінки функції верхньої та нижньої кінцівок?

- ✓ А. Модифіковану шкалу Ашворта
- В. Тест Берга
- С. Шкалу Борга
- Д. Індекс Бартел
- Е. Мануальне м'язове тестування

37. У чоловіка спостерігається перевага поздовжніх розмірів тіла над поперечними — довгі та тонкі кінцівки, довга та тонка шия, вузькі плечі, крилоподібні лопатки, вузька та плоска грудна клітка, гострий надчеревний кут, слабко розвинені м'язи та незначні жирові відкладення. Укажіть тип тілобудови чоловіка.

- А. Ендоморфний
- В. Мезоморфний
- ✓ С. Астенічний
- Д. Нормостенічний
- Е. Гіперстенічний

38. Яке показання до проведення постурального дренажу бронхів?

- А. Кровохаркання
- В. Остеохондроз як супутня патологія у разі вертеброгенної опосередкованості
- ✓ С. Застій секрету в бронхіальному дереві
- Д. Біль у ділянці грудної клітки
- Е. —

39. У пацієнта діагностовано ДЦП. Що з нижченаведеного може обмежувати використання терапевтичних вправ у воді?

- А. Спастичний парепарез
- ✓ В. Епілептичний напад
- С. Затримка психічного розвитку
- Д. —
- Е. Контрактури

40. У пацієнтки віком 34 роки під час обстеження колінного суглоба виявлено пошкодження і запальні

зміни сухожилків і сухожилкових піхв, які в результаті призвели до обмеження його рухливості. Який тип контрактури виник у пацієнтки?

- А. Неврогенний
- В. Міогенний
- С. Артрогенний
- ✓ Д. Тендогенний
- Е. Десмогенний

41. Під час катання на ковзанах фігурист здійснив невдалий ротаційний рух у колінному суглобі. У цей момент він відчув хрускіт і біль у коліні, згодом з'явився набряк. Об'єктивно спостерігається: коліно помірно набрякле, рухи обмежені та болісні. Позитивний латеральний тест МакМюррея. Пошкодження якої структури колінного суглоба потрібно запідозрити першочергово?

- ✓ А. Латерального меніска
- В. Передньої хрестоподібної зв'язки
- С. Колатеральної зв'язки
- Д. Задньої хрестоподібної зв'язки
- Е. Медіального меніска

42. Під час проведення терапевтичних вправ у відділенні реабілітації пацієнт, який переніс інфаркт міокарда, втратив свідомість. На ЕКГ виявлено: фібриляція шлуночків. Яка невідкладна допомога необхідна пацієнту?

- ✓ А. Дефібриляція
- В. Антиаритмічна терапія
- С. Електростимуляція
- Д. Знеболення
- Е. Вагусні проби

43. Пацієнт, який переніс інсульт, готується до розширення рухового режиму з наступною вертикалізацією положення тіла. Сила якого м'яза визначає можливість утримання тулуба у вертикальному положенні?

- А. Великого ромбоподібного м'яза
- В. Верхнього заднього зубчастого м'яза
- С. М'яза-випрямляча хребта
- Д. Найширшого м'яза спини
- Е. Трапецієподібного м'яза

44. Після вечірнього тренування, вранці рівень сечовини в крові у спортсмена підвищився до 8,5 ммоль/л. Наступного ранку реакція повторилася. Як оцінити отримані результати?

- А. Затяжний характер процесів відновлення
- В. Адекватна переносимість фізичного навантаження
- С. Недостатнє фізичне навантаження
- Д. Надмірне фізичне навантаження
- Е. Помірне фізичне навантаження

45. До якого виду реабілітаційних заходів належить налаштування середовища на роботі та вдома?

- А. Фізична терапія
- В. Ерготерапія
- С. Нейропсихофізіологічні втручання
- Д. Медичні втручання
- Е. Нутритивна терапія

46. Під час проведення терапевтичних вправ у пацієнта віком 27 років із тетраплегією виник сильний головний біль. Об'єктивно виявлено: АТ — 220/160 мм рт. ст., пульс — 50/хв. Спостерігається виражена пітливість по задній частині шиї та на чолі. Під час мануального обстеження виявлено: сечовий міхур розтягнутий, пальпується над лобковою кісткою. Яке втручання потрібно першочергово провести для покращення стану пацієнта?

- А. Ввести гіпотензивний препарат для зниження артеріального тиску
- В. Ввести знеболювальний препарат для зняття гловного болю
- С. Замінити катетер і спустити сечу із сечового міхура
- Д. Надати горизонтальне положення
- Е. Ввести петлевий діуретик

47. Під час проведення мануального м'язового тестування сили м'язів, що розгинають гомілку, лікар ФРМ встановив, що пацієнт може долати невеликий спротив, при цьому амплітуда руху у колінному суглобі була неповною. Який сегмент спинного мозку, найімовірніше, уражений у пацієнта?

- А. L1
- В. L4
- С. L3
- Д. L2
- Е. L5

48. Що належить до зовнішніх критеріїв дозування фізичних вправ?

- А. Ознаки втоми
- В. Економічні витрати
- С. Настрій під час процедури
- Д. Показники ЧСС
- Е. Обсяг, інтенсивність

49. Пацієнт віком 52 роки скаржиться на набряк правої ноги, що поступово збільшувався протягом останніх 12-ти місяців. Під час натискування великим пальцем у нижній третині гомілки ямка не утворюється, шкіра нижньої кінцівки має звичайний колір, не гаряча на дотик, пацієнт вказує на те, що його нога просто «важка». Травмування заперечує. Яка найімовірніша причина набряку?

- А. Лімфедема
- В. Хронічна венозна недостатність
- С. Хронічна серцева недостатність
- Д. Хронічна легенева недостатність
- Е. Бешихове запалення

50. Під час обстеження військово-службовця після мінно-вибухового

поранення встановлено діагноз: перелом хребта з ушкодженням спинного мозку на рівні спинномозкового сегмента C6. Яке порушення рухів є найбільш очікуваним у цьому разі?

- ✓ А. Розгинання у променево-зап'ястковому суглобі
- В. Згинання у плечовому суглобі
- С. Розгинання у ліктьовому суглобі
- Д. Відведення у плечовому суглобі
- Е. Згинання у променево-зап'ястковому суглобі

51. Під час оцінювання ступеня жиророзкладень лікар ФРМ використав пальпаторну методику, яка полягала у вимірюванні товщини захопленої між великим і вказівним пальцями складки шкіри з підшкірною жировою клітковиною. У якій ділянці прийнято проводити таке оцінювання?

- А. На рівні пупка
- В. У міжлопатковому просторі на рівні верхнього кута лопатки
- ✓ С. На 2-3 см нижче від пупка
- Д. У зоні передньої черевної стінки, яка найбільш випинає
- Е. На внутрішній поверхні стегна

33 52. Які компоненти пам'яті оцінюються під час тестування?

- ✓ А. Засвоєння, збереження, відтворення
- В. Засвоєння, моторна пам'ять, відтворення
- С. Спостереження, відтворення, вивчення
- Д. Емоційна пам'ять, збереження, відтворення
- Е. Вивчення, відтворення, підсвідомі пам'ять

34 53. Який провокаційний тест буде інформативним для діагностики уражень крижово-клубових суглобів?

- А. TUG
- В. Crush
- ✓ С. FABER
- Д. Pivot shift
- Е. Тест болісної дуги

35 54. Хто є найважливішим членом мультидисциплінарної реабілітаційної команди?

- А. Лікар ФРМ
- В. Фізичний терапевт
- С. Психотерапевт
- Д. Ерготерапевт
- ✓ Е. Пацієнт

36 55. Пацієнту віком 22 роки з муковісцидозом проводиться постуральний дренаж і перкусія середньої частки правої легені. Яке положення пацієнта є найбільш оптимальним під час проведення процедури?

- А. Лежачи з піднятим правим плечем на подушці та головою в одній площині з тазом
- В. Лежачи на клині з піднятим лівим плечем на подушці з головою нижче таза
- ✓ С. Лежачи на клині з піднятим правим плечем на подушці з головою нижче таза
- Д. Лежачи на животі з піднятим лівим плечем на подушці та головою в одній площині з тазом
- Е. Лежачи на клині з піднятим лівим плечем на подушці з головою вище таза

37 56. Пацієнт після травматичного ушкодження спинного мозку знаходиться на реабілітації у стаціонарному відділенні реабілітації. Скаржиться на порушення сечовипускання у вигляді постійних мимовільних підтікань сечі на фоні зниженого відчуття наповнення сечового міхура. З порушенням функції якої структури сечовидільної системи пов'язані такі симптоми?

- А. Детрузора сечового міхура
 В. Клапанів сечоводів
 С. Поздовжніх м'язів уретри
 D. Внутрішнього сфінктера сечового міхура
 Е. Зовнішнього сфінктера сечового міхура
57. У тенісиста діагностовано тендиніт одного з м'язів поясу верхньої кінцівки, що зумовлює тертя сухожилка з акроміальним відростком лопатки. Сухожилок якого м'яза уражений?
- А. Підостьового
 В. Надостьового
 С. Дельтоподібного
 D. Малого круглого
 Е. Великого круглого
58. Пацієнт під час візиту до лікаря ФРМ скаржиться на відчуття нестійкості та труднощі з приводу утримання рівноваги. Який тест доцільно провести в цьому разі?
- А. Берга
 В. Френчай
 С. Гофмана
 D. Беккера
 Е. Фукса-Розенталь
59. Яким повинне бути співвідношення натискань на грудну клітку та штучним диханням під час проведення серцево-легеневої реанімації у разі констатації раптової зупинки кровообігу в дорослого пацієнта?
- А. 30:2
 В. 15:2
 С. 5:2
 D. 5:1
 Е. 10:1
60. Пацієнт віком 58 років скаржиться на хронічний біль у колінних суглобах, який погіршується під час побутових навантажень і в стані спокою. Після обстеження лікар ФРМ діагностує остеоартрит. Пацієнт має надмірну вагу, веде малорухливий спосіб життя і зацікавлений у пошуку ефективних методів зменшення болю. Який із нижченаведених методів буде найефективнішим для зменшення хронічного болю в пацієнта?
- А. Використання нестероїдних протизапальних препаратів
 В. Регулярні фізичні вправи низької інтенсивності
 С. Використання ультразвукової терапії
 D. Заняття йогою
 Е. Використання теплової терапії
61. Що визначається як максимальний стимул під час дослідження нервової провідності протягом електронейроміографії?
- А. Найвища інтенсивність подразника, яку може перенести пацієнт
 В. Стимул, за межами якого відбувається подальше збільшення викликаной амплітуди
 С. Стимул, який на 20-30% перевищує порогову стимуляцію
 D. Будь-який стимул, який перевищує пороговий стимул
 Е. Стимул, за межами якого не відбувається подальшого збільшення викликаной амплітуди
62. Завдяки якому методу можна досягти розвантаження міжхребцевих дисків і суглобів, зменшити тиск на корінці спинномозкових нервів?
- А. Тейпування
 В. Ізометричних терапевтичних вправ
 С. Витягіння
 D. Позиціонування
 Е. Дзеркальної терапії
63. Пацієнт віком 53 роки перебуває в реабілітаційному відділенні з приводу ХОЗЛ і скаржиться на ранковий кашель, поганий настрій, запаморочення, слабкість. Показник функції зовнішнього дихання ОФВ1/ФЖЄЛ становить 60%, індекс маси тіла — 18 кг/м². Що у цього пацієнта є прогностичним фактором несприятливого перебігу реабілітаційного процесу?

- A. Запаморочення
- B. Депресивний стан
- C. Підвищена втомлюваність
- ✓ D. Зменшення індексу маси тіла
- E. Ранковий кашель

✓ 64. Пацієнту віком 23 роки 2 тижні тому зняли гіпсову іммобілізацію, що була пов'язана з переломом маломілкової кістки в нижній третині. Лікар призначив 30% осьового навантаження на уражену нижню кінцівку. Який із допоміжних засобів пересування найбільш доцільно призначити пацієнту з огляду на найбільшу ефективність щодо відновлення ходьби та безпечність із урахуванням того, що пацієнт планує їх використовувати під час ходьби на вулиці?

- A. Стандартну одноопорну палицю
- ✓ B. Милиці
- C. Чотирьохопорну палицю
- D. Ходунки
- E. Палицю з рухомою опорою

65. У реабілітаційному відділенні перебуває пацієнт із дегенеративним захворюванням поперекового відділу хребта. Якими інструментами реабілітаційного оцінювання доцільно скористатися для визначення результату терапевтичних інтервенцій у цьому разі?

- A. Візуально-аналоговою шкалою болю
- B. Анкетною якості життя
- ✓ C. Шкалою Освестрі
- D. Шкалою Гартріса
- E. Шкалою болю в спині Квебек

✓ 66. Яка шкала використовується для оцінки когнітивного статусу пацієнта?

- A. GCS
- ✓ B. MMSE
- C. FIM
- D. HADS
- E. FOUR

67. Фахівець із реабілітації проводить оцінювання ходи та рівня моторної активності у семирічного

хлопчика. Відзначається слабкість і зменшення об'єму м'язів ніг. Хода широкими кроками по вигляду нагадує перевалювання «качину ходу». Утруднення при підйманні сходами та вставанні зі стільця без допомоги рук. Позитивний симптом Говерса. Яке порушення ходи спостерігається у хлопчика?

- ✓ A. Гіперкінетична хода
- B. Нейропатична хода
- C. Міопатична хода
- D. Геміплегічна/геміпаретична хода
- E. Паркінсонічна хода

✓ 68. Пацієнту віком 34 роки успішно трансплантували праву руку після втрати кінцівки. Він проходить реабілітацію, але скаржиться на фантомні болі та складність у сприйнятті нової кінцівки як частини свого тіла. Лікувальна команда вирішує впровадити спеціальні вправи для перепрограмування коркових зв'язків у головному мозку. Яка головна мета реабілітації цього пацієнта після трансплантації руки?

- ✓ A. Відновлення образу руки в корі головного мозку
- B. Поліпшення м'язової сили
- C. Контроль набряку
- D. Запобігання інфекції
- E. Підвищення рухливості суглобів

✓ 69. Хто з фахівців затверджує індивідуальний реабілітаційний план?

- ✓ A. Лікар ФРМ
- B. Фізичний терапевт
- C. Соціальний працівник
- D. Ортезист-протезист
- E. Ерготерапевт

✓ 70. Якою є кіркова регуляція спінальних центрів сечовиділення?

- A. Однобічною гомолатеральною
- B. Правобічною
- ✓ C. Двобічною
- D. Однобічною контрлатеральною
- E. Лівобічною

71. Пацієнт звернувся до лікаря ФРМ зі скаргами на біль, оніміння та порушення здатності визначати

розташування правої руки в просторі. Після обстеження встановлено, що величина сили всіх м'язів правої верхньої кінцівки становила по 5 балів за ММТ. Також встановлено порушення поверхневої чутливості. Який із нижченаведених симптомів вказує на порушення поверхневої чутливості у цього пацієнта?

- А. Порушення кінестезії
- В. Біль
- С. Порушення статестезії
- Д. Порушення дискримінації
- Е. Порушення пропріоцепції

72. Пацієнт віком 55 років звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на кашель вранці з виділенням в'язкого зеленого мокротиння, задишку під час невеликого фізичного навантаження, стомлюваність, порушення сну. Погіршення стану відчув близько двох тижнів тому, пов'язує з перенесеною вірусною інфекцією. Кашель щоранку турбує протягом 10-ти років. Працює в деревообробному цеху, без систем вентиляції та засобів респіраторного захисту. Курить 20-30 сигарет на добу більше 35 років. Після двотижневого курсу медикаментозного лікування пацієнта скеровано на консультацію до лікаря фізичної та реабілітаційної медицини. Що з нижченаведеного найбільш доречно включити у зміст реабілітаційного обстеження цього пацієнта?

- А. Оцінювання функції ковтання
- В. Оцінювання умов праці
- С. Оцінювання патерну дихання
- Д. Когнітивне оцінювання
- Е. Оцінювання соціального статусу

73. Під час проведення поединку з боксу спортсмен отримав покаут і втратив свідомість. Лікар змагань діагностував закриту черепно-мозкову травму. Який компонент лікування є обов'язковим у цьому разі?

- А. Протисудомна терапія
- В. Протизапальна терапія
- С. Зниження моторної збудливості
- Д. —
- Е. Аналгезія

74. Руку пацієнта віком 24 роки зачисло уламками в ділянці плеча. Пацієнт може рухати пальцями кисті, але сила м'язів знижена до 3/5 за ММТ. Який вид пошкодження периферичних нервів найімовірніший у цьому разі?

- А. Розтягнення
- В. Перерізання
- С. Невротмезис
- Д. Аксонотмезис
- Е. Невропраксія

75. У пацієнта після черепно-мозкової травми під час огляду встановлено: оцінка за шкалою МоСА становить 27 балів, за тестом балансу Берга — 25 балів, індекс Бартел — 80 балів. Який вид втручання необхідно призначити першочергово?

- А. Тренування навичок самообслуговування
- В. Бобат-терапію
- С. Вправи на розвиток пам'яті та концентрації уваги
- Д. Тренування рухових навичок та умінь
- Е. Вправи на рівновагу

76. За результатами огляду пацієнта з бронхіальною астмою лікарем ФРМ встановлено збільшення передньо-заднього розміру грудної клітки у верхній частині, горизонтальне положення ребер, згладженість міжреберних проміжків, надключичних та підключичних ямок з обох боків. Для якої форми грудної клітки характерні виявлені ознаки?

- А. Кілеподібної
- В. Конічної
- С. Астматичної
- Д. Циліндричної
- Е. Бочкоподібної

52 77. Що з нижченаведеного має найбільшу ефективність щодо попередження набряку кукси в гострому періоді реабілітації пацієнта після ампутації кінцівки?

- A. Мобілізація рубця
- B. Позиціонування
- C. Компресійна терапія
- D. Ідеомоторні вправи
- E. Тактильна стимуляція

53 78. Під час огляду пацієнтки віком 38 років із діагнозом: вертеброгенна цервікалія в стадії загострення — виявлено підвищений тонус та болісність верхньої частини трапецієподібного м'язу праворуч. У якому напрямку повинен виконати розтяг м'язів фахівець під час фази розслаблення, виконуючи методику постізометричної релаксації?

- A. У напрямку згинання шиї та голови, повертання вправо
- B. У напрямку розгинання шиї та голови, повертання вправо
- C. У напрямку повертання вправо шиї та голови, нахил вправо
- D. У напрямку розгинання шиї та голови, бокового згинання вправо
- E. У напрямку згинання шиї та голови, бокового згинання вліво

79. Спортсмен-спринтер на старті в момент відриву ноги від землі відчув біль по задній поверхні нижньої третини лівої гомілки. Під час обстеження виявлено, що у пацієнта відсутнє підшопвне згинання лівої стопи. Яке з нижченаведених порушень функціонування, найімовірніше, буде встановлено в пацієнта?

- A. Порушення ходьби на «п'ятках»
- B. Порушення згинання у лівому колінному суглобі
- C. Порушення розгинання пальців стопи
- D. Порушення ходьби на «носках»
- E. Порушення згинання пальців стопи

80. У пацієнта після одnobічної трансфеморальної ампутації розвинулося бокове викривлення по-

перекового відділу хребта. Зміцнення яких м'язів зменшить нахил таза та ступінь сколіотичної кривизни хребта?

- A. Клубово-поперекові м'язи
- B. Глибокі м'язи-розгиначі хребта
- C. Квадратний м'яз і м'язи стегна
- D. Поверхневі м'язи спини
- E. М'язи черевної стінки та сідничні м'язи

54 81. Лікар ФРМ спостерігає, як фізичний терапевт розпочинає перше терапевтичне заняття з пацієнтом, що переніс гостре порушення мозкового кровообігу в басейні лівої мозкової артерії, заняття орієнтоване на навчання техніці підійматися сходами. Для забезпечення максимальної безпеки, де саме повинен знаходитися фізичний терапевт?

- A. Ліворуч від пацієнта на одну сходинку нижче
- B. Праворуч від пацієнта на одну сходинку нижче
- C. Праворуч від пацієнта на одну сходинку вище
- D. Позаду від пацієнта
- E. Ліворуч від пацієнта на одну сходинку вище

55 82. Пацієнт після травматичного ушкодження спинного мозку скаржиться на зниження можливості довільного утримання сечі при появі перших позивів до сечовипускання. Із порушенням функції якої структури сечовидільної системи насамперед пов'язані такі симптоми?

- A. Клапана сечоводів
- B. Детрузора сечового міхура
- C. Поздовжніх м'язів уретри
- D. Зовнішнього сфінктера сечового міхура
- E. Внутрішнього сфінктера сечового міхура

83. Під час обстеження пацієнта віком 30 років встановлено, що він не може самотійно розігнути ліву кисть у променево-

зап'ястковому суглобі. Обсяг пасивних рухів (розгинання) у променево-зап'ястковому суглобі 90°. Сила м'язів, що розгинають кисть — 2/5 балів за MMT. Із анамнезу відомо, що 2 місяці тому пацієнта прооперовано з приводу вивиху голівки променевої кістки. Яка найімовірніша причина виникнення такої симптоматики?

A. Несвоєчасно встановлене пошкодження м'язів, що розгинають ліву кисть

B. Суглобова контрактура променево-зап'ясткового суглоба

C. Нормальний процес відновлення

D. Пошкодження нерва

E. Неякісна реабілітація

84. Пацієнт, який переніс ішемічний інсульт, перебуває у довготривалому періоді реабілітації. За якою шкалою на 90-ий день від початку захворювання визначається інтегральний показник якості надання реабілітаційної допомоги в цьому разі?

A. Модифікованою шкалою Ренкіна

B. Монреальською шкалою оцінювання когнітивних функцій

C. Шкалою Ашворта

D. Шкалою Шваб

E. Госпітальною шкалою тривоги та депресії

85. Пацієнт віком 58 років переніс артропластику колінного суглоба 2 тижні тому. Під час первинного огляду на консультації з лікарем ФРМ пацієнт скаржиться на помірний біль у періопераційній ділянці, який посилюється при рухові, та відчуття слабкості у м'язах стегна. Він також помітив легку набряклість навколо операційного шва. Загальний стан пацієнта задовільний, післяопераційний період протікав без ускладнень. Яку з нижченаведених реабілітаційних інтервенцій потрібно виконати першочергово в цьому разі?

A. Включення вправ на зміцнення м'язів

B. Розробку індивідуального реабілітаційного плану

C. Впровадження аеробних навантажень

D. Поступове збільшення навантажень

E. Оцінку обсягу рухів і болю

86. Під час проведення реабілітаційних інтервенцій пацієнт відчув серцебиття, запаморочення, слабкість. На ЕКГ виявлено: тахікардія з вузькими комплексами QRS. Яка першочергова невідкладна допомога має бути надана пацієнту?

A. Глибоке дихання

B. Затримка дихання при вдиху

C. Заспокійливі препарати

D. Горизонтальне положення

E. Вагусні проби

87. Пацієнт після ішемічного інсульту скаржиться на труднощі з ходьбою, зокрема на обмеження дистанції, яку він може пройти самостійно. Лікар ФРМ хоче встановити довгострокову ціль для покращення його рухових навичок. Пацієнт налаштований на активну участь у процесі реабілітації. Яка з нижченаведених цілей є прикладом правильно встановленої довгострокової цілі у SMART-форматі?

A. Забезпечити пацієнту комфорт під час пересування

B. Збільшити дистанцію ходьби пацієнта до 500 метрів без допомоги протягом 6-ти місяців

C. Поліпшити ходьбу пацієнта до кінця тижня

D. Відновити повну мобільність пацієнта протягом 1-го місяця

E. Навчити пацієнта ходити з використанням тростини протягом 3-х днів

88. Яке дослідження проводиться з метою визначення життєвої ємності легень, її складників та оцінки форсованого видиху?

- А. Тест із затримкою дихання
 В. Пікфлоуметрія
 С. Вимірювання пікової швидкості видиху
 Д. Спірометрична проба з бронхолітиком
 Е. Спірометрія
89. Пацієнт скаржиться на знижену чутливість у нижніх кінцівках. Лікар вирішує провести обстеження, щоб оцінити тактильну чутливість його ніг. Який метод використовується для перевірки тактильної чутливості нижньої кінцівки?
- А. Дотик жмутом вати
 В. Доторкання камертонами з теплою та прохолодною водою
 С. Рух дистальної фаланги великого пальця ноги вгору-вниз
 Д. Дотик одноразовою голкою
 Е. Дотик медичним пінцетом
90. У пацієнта спостерігається сутулість постави, голова та шия витягнуті вперед. Ходьба дрібними кроками зі згинанням у колінах, відомими як «човгаюча хода». Швидко починати, зупинятися або змінювати напрямок руху складно, є тенденція до ретропульсії (падіння назад під час стояння). Яке порушення ходи виявлено в пацієнта?
- А. Паркінсонічна хода
 В. Сенсорна хода
 С. Невропатична хода
 Д. Геміплегічна/геміпаретична хода
 Е. Міопатична хода
91. У пацієнта віком 43 роки через 6 місяців після перенесеного ішемічного інсульту спостерігається підвищення тону м'язів у правих кінцівках, яке виявляється протягом усього руху, але не утруднює виконання пасивних рухів. Ступінь підвищення тону м'язів за шкалою Ашворта — 3/5 балів. Що необхідно включити в програму реабілітаційних втручань у цьому разі?
- А. Сенсорну інтеграцію
 В. Відновлення м'язової сили
 С. Менеджмент спастичності
 Д. Відновлення когнітивних функцій
 Е. Відновлення балансу
92. Який клінічний прояв є ознакою декомпенсації хронічної венозної недостатності на нижніх кінцівках?
- А. Дерматит
 В. Трофічні виразки
 С. Слабкість у кінцівках
 Д. Блідість шкірних покривів
 Е. Свербіж шкіри
93. Пацієнт віком 60 років скаржиться на швидку стомлюваність. Об'єктивно спостерігається: стоячи із заплющеними очима, похитується, втрачає рівновагу, тонус скелетних м'язів знижений. Яка структура мозку, найімовірніше, уражена в пацієнта?
- А. Мозочок
 В. Гіпоталамус
 С. Прецентральної звивини кори великих півкуль
 Д. Таламус
 Е. Базальні ганглії
94. У дітей із церебральним паралічем оцінка стану кульшового суглоба вимірюється відсотком міграції Реймера (the Reimers Migrations percentage (MP)). За якого показника MP показано оперативне лікування?
- А. Більше ніж 20%
 В. Більше ніж 30%
 С. Більше ніж 60%
 Д. Більше ніж 40%
 Е. Більше ніж 50%
95. Яка шкала найчастіше використовується для прогнозування результатів у реабілітації пацієнтів з інсультом?

1 A. NIHSS

B. Шкала когнітивного функціонування Ранчо Лос Амігос

C. Індекс Бартел

D. MMSE

E. FIM

96. Після мінометного обстрілу військовослужбовець отримав уривання вибуховою хвилею. Відповідно до чинних стандартів, що з нижченаведеного повинно бути виконано першочергово?

A. Огляд дихальних шляхів

B. Оцінка свідомості

C. Оцінка наявності та зупинка кровотечі

D. Оцінка роботи серця та забезпечення непрямого масажу серця (за потреби)

E. Забезпечення ефективності дихання

65 97. Пацієнт віком 58 років переїс ішемічний інсульт 3 тижні тому. Після стабілізації стану його перевели до відділення реабілітації для відновлення функціональних навичок. Лікар ФРМ має оцінити стан пацієнта, щоб визначити реабілітаційні задачі на основі компонента активності. Який із нижченаведених інструментів реабілітаційного оцінювання є стандартним для здійснення цього завдання?

A. Візуальна аналогова шкала (ВАШ)

B. Виявлення мінімальних психічних порушень (MMSE)

C. Мануально-м'язове тестування (MMT)

D. Тест 12-хвилинної ходьби

9 E. Шкала функціональної незалежності (FIM)

66 98. Перед змаганнями з волейболу, лікар планує провести обстеження команди із визначення типу реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження. Яку з нижченаведених проб використає лікар?

A. Летунова

B. Мартіне-Кушелевського

C. Вальсальви

D. Флека

E. Штанге

99. Дворічній дитині встановлено діагноз: ДЦП, подвійна геміплегія (V рівень GMFCS). Відсоток міграції Реймера становить 30%. Яке втручання є найефективнішим для профілактики вивиху кульшового суглоба та контрактур нижніх кінцівок у цьому разі?

A. Масаж розслаблюючий із подальшими вправами на розведення стегон

B. —

C. Систематичні вправи на розведення стегон, розтяжки

D. Позиціонування у положенні сидючи з розведенням ніг

E. Використання вертикалізації 60-90 хв на добу

100. Під час огляду пацієнта лікар ФРМ встановив, що ребра мають горизонтальне розташування, передньо-задній і поперечний розміри грудної клітки однакові, міжреберні проміжки симетричні, епігастральний кут тупий. Для якої форми грудної клітки характерні виявлені ознаки?

A. Бочкоподібної

B. Циліндричної

C. Плоскої

D. Астенічної

E. Конічної

101. У жінки під час проведення стимуляційної електронейроміографії серединного нерва на правому передпліччі в ділянці карпального каналу виявлено збільшення латентності періоду М-відповіді та зменшення швидкості проведення імпульсу. Який патологічний стан виник у пацієнтки?

- ✓ **A.** Демієлінізація
- B.** Нейротмезис
- C.** Міопатія
- D.** Аксональне ураження
- E.** Радикулопатія

61 102. Пацієнт на прийомі в лікаря ФРМ розповідає, що незважаючи на реабілітацію після геморагічного інсульту, відзначає слабкість і порушення функції правої верхньої кінцівки. Який інструмент доцільно застосувати для оцінки функції руки?

- A.** Модифіковану шкалу Ренкіна
- ✓ **B.** Індекс мобільності Рівермід
- C.** Тест Френчай
- D.** Індекс Бартел
- E.** Тест FIM

103. Під час проведення клінічного огляду у пацієнтки із загостренням множинного склерозу виявлено ознаки підвищення м'язового тону у вигляді спастичності м'язів рук і ніг (за Модифікованою шкалою Ашворта — 3/5 балів), що значно обмежує повсякденне функціонування та ускладнює догляд. Яке призначення найбільш доцільне під час лікування генералізованої спастичності?

- A.** Введення ботулотоксину А у цільові м'язи
- B.** Баклофен перорально
- C.** Пульс-терапія метилпреднізолоном
- ✓ **D.** Функціональна електростимуляція м'язів у міорелаксуючому режимі
- E.** Селективна дорзальна ризотомія

104. Під час обстеження пацієнта з перенесеним мозковим інсультом лікар фізичної та реабілітаційної медицини фіксує порушення мовлення. Відзначається утруднення при висловлюванні власних думок, заплутаність, «переставляння» звуків у словах і слів у реченнях. Порушено розуміння розмовної мови та значень деяких слів. При цьому вимова окремих звуків збережена. Яке порушення мовлення виникло

в пацієнта?

- A.** Дислалія
- B.** Дизартрія
- C.** Дисфонія
- ✓ **D.** Вербальна апраксія
- E.** Афазія

68 105. Пацієнтці віком 47 років встановлено діагноз: гострий комплексний регіональний больовий синдром (CRPS) I типу з набряком. Які медикаментозні засоби доцільно призначити в програмі реабілітації?

- A.** Баклофен
- B.** Диметилсульфоксид для місцевого застосування
- ✓ **C.** Преднізолон
- D.** Ібупрофен
- E.** —

65 106. Пацієнту віком 45 років діагностовано: гострий інфаркт міокарда. Який обсяг реабілітаційної допомоги показаний пацієнту в гострому періоді захворювання?

- A.** Помірний
- B.** Дуже високий
- ✓ **C.** Низький
- D.** Середній
- E.** Високий

107. Спортсмен під час забігу на півмарафонську дистанцію впав і втратив свідомість. Кардіореанімаційна бригада, яка прибула на місце, надала допомогу та встановила діагноз гострого фізичного навантаження. Яка зміна на ЕКГ є найбільш характерною для цього стану?

- A.** Порушення ритму за типом екстрасистолії
- B.** Деформація QRS комплексу
- ✓ **C.** Зміщення сегмента ST нижче ізолінії на 2 мм
- D.** AV-блокада Мобітц 2
- E.** Скорочення інтервалів PQ, QT

108. У пацієнта віком 67 років лікар ФРМ запідозрив розвиток неглекту після повторного мозкового інсульту. За допомогою якого реа-

білітаційного інструменту оцінювання можна підтвердити синдром просторового ігнорування в цьому разі?

- А. Шкали ASIA
- В. Індексу Бартел
- С. Тесту Альберта
- Д. Проби Ромберга
- Е. Шкали Фугл-Мейера

109. Із метою підвищення ефективності роботи мультидисциплінарної реабілітаційної команди, хто повинен застосовувати модель SMART для постановки мети кожного етапу реабілітації?

- А. Лікар ФРМ
- В. Безпосередньо сам пацієнт
- С. Пацієнт і його оточення
- Д. Фізичний терапевт
- Е. Кожен фахівець із реабілітації

110. Під час обстеження пацієнта, який переніс перелом лівої стегнової кістки та проходить лікування консервативним методом, встановлено, що обсяг згинання у лівому колінному суглобі — 140° , а розгинання — 180° . За результатами рентгенологічного обстеження лівого колінного суглоба патологічних змін не виявлено. Який вид обмеження рухливості спостерігається у пацієнта?

- А. Десмогенна контрактура
- В. Псевдом'язова контрактура
- С. М'язова контрактура
- Д. Фібротична контрактура
- Е. Кістковий анкілоз

111. Пацієнт віком 73 роки, який хворіє на цукровий діабет і має дефіцит кальцію, перебуває в реабілітаційному відділенні з переломом нижньої третини маломілкової кістки лівої гомілки. Що у цього пацієнта може бути прогностичним фактором несприятливого перебігу реабілітаційного процесу?

- А. Неконсолідований перелом
- В. Консолідований перелом
- С. Інтермедіальний кістковий мозоль
- Д. Періостальний кістковий мозоль
- Е. Ендостальний кістковий мозоль

112. У результаті перенесеного оперативного лікування колінного суглоба у пацієнта сформована післяімобілізаційна контрактура. Для збільшення амплітуди розгинання пацієнт самостійно розгинає коліно, утримуючи його у крайній точці амплітуди за допомогою напруження м'язів розгиначів. Як називається цей тип розтягнення?

- А. Динамічний
- В. Активний
- С. Постізометрична релаксація
- Д. Пасивний
- Е. Балістичний

113. Пацієнт віком 24 роки після ДТП отримав травму спинного мозку на рівні шийного відділу хребта. Після стабілізації стану пацієнта через три тижні перевели до реабілітаційного відділення. Під час реабілітаційного обстеження пацієнта встановлено, що неврологічний рівень — С6, повне ураження AIS A. Під час заняття з фізичним терапевтом пацієнт відчув пульсуючий головний біль, закладеність носа, виражену пітливість. Об'єктивно спостерігається: гіперемія шкіри обличчя, виражений периферичний ангіоспазм (холодні та бліді кінцівки), пілореакція, гіпергідроз. Який стан виник у пацієнта?

- А. Симпато-адреналовий криз
- В. Тиреотоксичний криз
- С. Автономна дисрефлексія
- Д. Транзиторна ішемічна атака
- Е. Гострий розлад мозкового кровообігу

114. Пацієнт, який переніс інсульт, знаходиться на стаціонарній реабілітації. Лікар ФРМ вирішує використати спеціальний метод обстеження для оцінки здатності пацієнта

єнта керувати своєю позою та для моніторингу прогресу в процесі лікування. Цей метод визначає центр тиску пацієнта, коли той стоїть на платформі, і допомагає в діагностиці та реабілітації, забезпечуючи біологічний зворотний зв'язок. Який метод обстеження, найімовірніше, використає лікар у цьому разі?

- А. Тест «Встань та йди»
- В. Тест «Чотири квадрати»
- С. Тест Берга
- Д. Стабілометрию
- Е. Тест двох вагів

115. У пацієнта, який перебуває в реабілітаційному відділенні, виявлено підвищений артеріальний тиск 180/100 мм рт. ст. і діагностовано гіпертензивний криз, неускладнений. ЧСС — 60/хв. Який із нижченаведених лікарських засобів рекомендовано використати для лікування пацієнта в цьому разі?

- А. Амлодипін
- В. Бісопролол
- С. Верапаміл
- Д. Фуросемід
- Е. Ніфедипін

116. Які складники постановки цілей у реабілітації за форматом SMART?

- А. Конкретні, мотивуючі, досяжні (реалістичні), значимі (релевантні), обмежені в часі
- В. Конкретні, вимірювані, досяжні (реалістичні), значимі (релевантні), обмежені в часі
- С. Комплексні, цілісні (холістичні), досяжні (реалістичні), значимі (релевантні), командні
- Д. Комплексні, цілісні, досяжні (реалістичні), значимі (релевантні), спрямовані на особу (персоніфіковані)
- Е. Комплексні, вимірювані, досяжні (реалістичні), значимі (релевантні), обмежені в часі

117. У пацієнтки із розсіяним склерозом під час проведення реабілітації лікар ФРМ відзначає наяв-

ність динамічної атаксії. Який метод оцінювання може підтвердити цей симптом?

- А. Проба Рінне
- В. Оцінювання ознаки Стюарта-Холмса
- С. Проба Нойка-Ганева
- Д. Проба на діадохокінез
- Е. Стопний тест Вестфалі

118. Пацієнт віком 32 роки перебуває в спеціалізованому реабілітаційному центрі з нижнім парапарезом унаслідок травми спинного мозку (AIS C, неврологічний рівень Th11). За результатами ММТ більше половини ключових м'язів нижніх кінцівок мають 2/5 балів. Метою для пацієнта є відновлення здатності самостійно ходити. Використання якого з нижченаведених методів є найефективнішим для реалізації поставленої мети?

- А. Електростимуляція м'язів
- В. Мануальна терапія
- С. Віртуальна реальність
- Д. Гідротерапія
- Е. Роботизована система

119. Під час проведення кліноста-тичної проби у пацієнта виявлено уповільнення ЧСС на 20/хв відразу після зміни положення на горизонтальне. Який висновок має зробити лікар ФРМ?

- А. Знижений тонус симпатичної нервової системи
- В. Підвищена реактивність парасимпатичної нервової системи
- С. Підвищений тонус симпатичної нервової системи
- Д. Знижений тонус парасимпатичної нервової системи
- Е. Знижена реактивність парасимпатичної нервової системи

120. Десятирічний хлопчик із дитячим церебральним паралічем має виражену спастичність м'язів нижніх кінцівок, що обмежує його рухливість і призводить до болю. Який із нижченаведених підходів найефективніший для зменшення

спастичності м'язів у хлопчика?

- А. Фізичні вправи низької інтенсивності
- В. Використання ботулотоксину
- С. —
- Д. Застосування електроміостимуляції
- Е. Вправи на розтягнення спастичних м'язів

121. Пацієнту віком 56 років встановлено діагноз: ішемічний інсульт у басейні задньої нижньої мозочкової артерії, бульбарний синдром. Об'єктивно спостерігається: дисфагія, дизартрія, дисфонія. Що необхідно включити в програму реабілітаційних втручань у цьому разі?

- А. Відновлення когнітивних функцій
- В. Менеджмент порушень ковтання
- С. Менеджмент спастичності
- Д. Сенсорну інтеграцію
- Е. Відновлення м'язової сили

122. У пацієнта віком 40 років встановлено діагноз: закрыта травма хребта, забій спинного мозку середнього ступеня тяжкості. Об'єктивно спостерігається: стан стабільний, млявий парапарез верхніх кінцівок і спастичний парапарез нижніх кінцівок. Який рівень ушкодження спинного мозку в пацієнта?

- А. T1-T2
- В. T12-L2
- С. L2-L3
- Д. C5-C7
- Е. C1-C2

123. Який кардіореспіраторний результат очікується від літньої людини, що бере участь у програмі аеробних тренувань?

- А. Відсутність змін ударного об'єму
- В. Відсутність змін у толерантності під час повсякденної діяльності
- С. Покращення $\dot{V}O_{2max}$
- Д. Погіршення $\dot{V}O_{2max}$, але збільшення швидкості ходьби
- Е. Відсутність змін ударного об'єму та зниження системного опору судин

124. Який діагностичний інструмент для оцінки функціональної незалежності найкраще обрати для пацієнта після гострого порушення мозкового кровообігу?

- А. Індекс Бартел
- В. Шкалу Ашворта
- С. Тест Берга
- Д. Шкалу NIHSS
- Е. Шкалу Борга

125. Яку структуру головного мозку лікар ФРМ оцінює під час обстеження функції зовнішнього дихання?

- А. Мозочок
- В. Проміжний мозок
- С. Таламус
- Д. Довгастий мозок
- Е. Середній мозок

126. Яка шкала буде найінформативнішою для оцінки м'язового тону пацієнта з хворобою Паркінсона під час проходження ним реабілітації?

- А. Тард'є
- В. Ашворта
- С. Вираженості екстрапірамідного тону
- Д. Освестрі
- Е. Пеннінгтона

127. Пацієнт віком 63 роки перебуває у відділенні реабілітації після перенесеного гострого розладу мозкового кровообігу в басейні правої середньомозкової артерії. Протягом обстеження лікарем фізичної та реабілітаційної медицини встановлено, що пацієнт погано ковтає воду та періодично закашлюється. Якого з фахівців реабі-

літації з огляду на безпеку пацієнта потрібно залучити в цьому разі першочергово?

- А. Терапевта мови та мовлення
- В. Ерготерапевта
- С. Фізичного терапевта
- Д. Дієтолога
- Е. Психолога

128. Пацієнт віком 65 років переїс ішемічний інсульт, має помірний парез лівої ноги та труднощі з підтримкою рівноваги під час руху, що призводить до порушення ходьби. Проживає в гірській місцевості. Під час оцінювання за шкалою Берга — 52 бали. Яка з нижченаведених методик є найефективнішою для відновлення здатності до ходьби?

- А. Тренування ходьби в природних умовах перебування пацієнта
- В. Тренування на біговій доріжці з підтримкою ваги тіла
- С. Вправи на стійкість і рівновагу
- Д. Використання ортезів на нижні кінцівки
- Е. Тренування з використанням ходунків

129. Яка найчастіша причина смерті пацієнтів із ШВЛ-залежною тетраплегією, що вижили в перші 24 год?

- А. Пролежнева інфекція
- В. Ниркова недостатність
- С. Сепсис
- Д. ТЕЛА
- Е. Пневмонія

130. Пацієнту після перенесеного інсульту з порушенням ковтання для визначення прогнозу реабілітації застосували шкалу оцінки ступеня дисфагії та отримали результат — 3 бали. Чим характеризується цей ступінь дисфагії?

А. —

В. Вживанням тільки рідкої їжі (вільне)

С. Нemoжливiстю приймати окремі види твердої їжі

Д. Нemoжливiстю проковтнути звичайну кількість їжі

Е. Вживанням тільки м'якої, напіврідкої їжі

131. Якими є особливості поранень і їх реабілітаційного менеджменту під час катастроф і конфліктів?

А. Надання допомоги здійснюється переважно висококваліфікованими фахівцями

В. Найбільш часті одиничні поранення

С. Наявність чіткого маршруту руху пацієнтів

Д. Чіткий документообіг гарантує зберігання та передачу необхідної інформації про характер поранення

Е. Часті інфекційні ускладнення

132. Пацієнтка віком 43 роки скаржиться на те, що не може утримати воду у роті, надуті щоку. Своє захворювання пов'язує з переохолодженням. Об'єктивно спостерігається: очна щілина зліва розширена, око не закривається, при наморщуванні лоба складки не утворюються, лівий кут рота опущений. Ліворуч — симптом Белла. Сльозотеча з очей. Мозочкових симптомів і розладу чутливості не виявлено. Під час подальшого обстеження пацієнтки який рефлекс знижується або не викликається у разі цієї патології?

А. Надбрівний рефлекс ліворуч

В. Корнеальний рефлекс праворуч

С. Надбрівний рефлекс праворуч

Д. Нижньощелепний рефлекс ліворуч

Е. Кон'юнктивальний рефлекс праворуч

133. Пацієнт віком 48 років упродовж 17-ти років хворіє на ревматоїдний артрит із ураженням обох кистей, колінних і кульшових суглобів. Який домен, згідно з НК

030:2022, характеризує проблеми пацієнта, які пов'язані з функціонуванням?

- А. Когнітивні функції
- В. Функції м'язової сили
- С. Підіймання і перенесення об'єктів
- Д. Сенсорні функції
- Е. Дрібна моторика кисті

134. У пацієнта віком 64 роки раптово виник геморагічний інсульт. Яке із завдань є пріоритетним у гострому реабілітаційному періоді?

- А. Відновлення балансу
- В. Адаптація до мовних порушень
- С. Профілактика ускладнень
- Д. Відновлення м'язової сили
- Е. Відновлення когнітивних функцій

135. Пацієнт віком 30 років отримав травму коліна під час гри у футбол. Після проведеної операції йому рекомендовано пройти реабілітаційну програму, яка включає фізичні вправи для зміцнення м'язів і відновлення рухливості. Пацієнт звертає увагу на біль у коліні під час вправ і набряк, що періодично виникає. Проте він також зазначає, що почав повертатися до повсякденної діяльності, але відчуває деякі обмеження у виконанні своїх звичних обов'язків на роботі та у побуті. Лікар ФРМ на черговому огляді планує оцінити прогрес пацієнта у реабілітації. Який із нижченаведених критеріїв буде визначальним для оцінки прогресу пацієнта?

- А. Розмір набряку в ділянці колінного суглоба
- В. Результати МРТ колінного суглоба
- С. Рівень болю під час виконання вправ
- Д. Тривалість реабілітаційного процесу
- Е. Обмеження в щоденній діяльності

136. Пацієнт із важким перебігом COVID-19 перебуває на стаціонарному лікуванні. Проведено оцінювання членами мультидисциплінарної реабілітаційної команди, за результатами якого призначено позиціонування. Які цілі цієї інтервенції?

- А. Оптимізація легеневої вентиляції, вентиляційно-перфузійного співвідношення та попередження виникнення ускладнень
- В. Зменшення задишки, очищення дихальних шляхів і тренування скелетних м'язів
- С. Нормалізація дихання, збільшення сили дихальних м'язів, збільшення екскурсії грудної клітки
- Д. Постійний моніторинг дихальних і гемодинамічних показників
- Е. Проведення активних вправ для кінцівок, тулуба, вправи для поліпшення повсякденної активності

137. Пацієнт віком 45 років скаржиться на відчуття пекучого болю в правій стопі, болісність під час носіння протеза. В анамнезі: трансформаторна ампутація справа внаслідок мінно-вибухової травми 6 місяців тому. Який вид реабілітаційного втручання допоможе зменшити больовий синдром?

- А. Еластичне бинтування кукси
- В. Дзеркальна терапія
- С. Бімануальна терапія
- Д. Терапія обмеженням руху
- Е. Ерготерапія

138. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на біль у шийному відділі хребта та надпліччі з іррадіацією в праву руку, слабкість м'язів руки та кисті. В анамнезі встановлено діагноз: невропатії променевого нерва правої руки. За результатами мануального м'язового тестування отримані результати: розгиначі передпліччя — 3/5 та згиначі кисті — 4/5 балів. Яке інструментальне обстеження найбільш доцільно призначити в цьому разі?

- А. Електронеурографію
- В. Ультразвукове обстеження плеча
- С. Рентгенографію шийного відділу хребта
- Д. Рентгенографію кисті
- Е. МРТ шийного відділу хребта

91 139. Хлопчик із прогресуючою м'язовою дистрофією Дюшена, неамбулаторна стадія, протягом довгого часу отримує лікування глюкокортикостероїдами. Яке типове ускладнення тривалого застосування таких препаратів необхідно враховувати під час планування та надання реабілітаційних послуг, зокрема із застосування терапевтичних вправ на розтягнення?

- А. Підвищення рівня цукру в крові
- В. Затримка статевого дозрівання
- С. Ожиріння
- Д. Затримка росту
- Е. Компресійні переломи хребців

92 140. Для пацієнта з дисфагією після гострого порушення мозкового кровообігу для профілактики аспірації ефективним є маневр із підтягуванням підборіддя. Який механізм дії цього маневру?

- А. Знижує глотковий тиск
- В. Пригнічує перистальтику м'язів глотки
- С. Зменшує екскурсію нижнього стравохідного сфінктера
- Д. Зменшує відкриття дихальних шляхів
- Е. Зменшує екскурсію верхнього стравохідного сфінктера

93 141. Після проведення проби Мартіне-Кушелевського у пацієнта збільшився артеріальний тиск зі 120/80 мм рт. ст. до 170/95 мм рт. ст., а пульс — із 72/хв до 140/хв. Для якого типу реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження характерні такі зміни?

- А. Дистонічного
- В. Гіпертонічного
- С. Гіпотонічного
- Д. Східчастого
- Е. Нормотонічного

142. У спортсмена-баскетболіста виявлено ознаки ураження ротаційної манжети плеча. Порушення якої функції за класифікацією МКФ найчастіше визначається при цьому стані?

- А. Стабільності суглоба
- В. Сприйняття болю
- С. Рухливості суглоба
- Д. Контролю довільного руху
- Е. М'язової витривалості

143. Пацієнта зі спинномозковою травмою на рівні T11-T12 через 3 тижні, коли стан стабілізувався, оглядає лікар ФРМ для вирішення питання про початок активної реабілітації. Що буде визначати остаточний прогноз реабілітації для цього пацієнта?

- А. Психологічний стан
- В. Соціальна підтримка
- С. Розвиток первинного захворювання
- Д. Індивідуальні цілі участі
- Е. Фактори зовнішнього середовища

94 144. Пацієнт віком 46 років перебуває в реабілітаційному відділенні з приводу ХОЗЛ. Показник функції зовнішнього дихання ОФВ1 становить 65%. Яка шкала дасть можливість оцінити результати реабілітаційних інтервенцій у цьому разі?

- А. HADS
- В. Ранчо
- С. Берга
- Д. Борга
- Е. NIHSS

145. Військовослужбовець отримав пошкодження спинного мозку внаслідок мінно-вибухової травми. Під час обстеження м'язової сили за мануальним м'язовим тестом встановлено, що відведення у плечово-

93 му суглобі з обох боків становить 5 балів, розгинання у правому зап'ястку — 5 балів, у лівому — 3 бали, розгинання у ліктьовому суглобі з обох боків — 2 бали. При оцінці поверхневої чутливості встановлено, що у сегментах C2-T1 чутливість становила 2 бали, у сегменті T2 — праворуч 2 бали, ліворуч — 1 бал, у сегменті T3 — з обох боків 0 балів. Оцініть неврологічний рівень пошкодження спинного мозку за шкалою AIS.

- A. C4
- B. C8
- C. C7
- D. C5
- 94 J. E. C6

96 146. Який показник є свідченням економізації фізіологічних функцій організму у відповідь на регулярні тренування?

- A. Тахікардія в стані спокою
- B. Збільшення ударного об'єму лівого шлуночка у спокої
- C. Брадикардія під час навантаження
- D. Тахікардія під час навантаження
- 97 J. E. Брадикардія в стані спокою

100 147. Укажіть побічний (передбачуваний) ефект під час проведення анаеробних тренувань.

- 98 J. A. Вироблення молочної кислоти
- B. Підвищення рівня ШОЕ
- C. Зниження рівня ШОЕ
- D. Збільшення жирових відкладень
- E. Підвищення вмісту холестерину в крові

148. Якою повинна бути частота натискань на грудну клітку під час проведення серцево-легеневої реанімації дорослому пацієнту?

- J. A. 100-120/хв
- B. 80-100/хв
- C. 120-140/хв
- D. 60-80/хв
- E. 40-60/хв

99 149. Яке дослідження дозволяє оцінити переносимість фізичного навантаження, що відповідає можливості виконання повсякденної активності?

- J. A. Тест із 6-хвилинною ходьбою
- B. Спірометрія
- C. Дослідження трансфер-фактора для оксиду вуглецю
- D. Кардіореспіраторний тест із фізичним навантаженням
- E. Плетизмографія

100 150. Яке втручання застосовується у пацієнтів із вестибулоатактичним синдромом для тренування рівноваги?

- A. Дозована ходьба
- J. B. Вправи з напівсферою
- C. Дихальні вправи
- D. Вправи на силу м'язів верхніх кінцівок
- E. Вправи для мімічних м'язів